

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Prulifloxacin 132.1mg

(퀴스논정, 유한양행)

☐ **제형, 성분함량 :**

- 1정 중 프룰리플록사신(Prulifloxacin) 132.1mg

☐ **효능 효과 :**

<유효균종>

이 약 프룰리플록사신의 활성성분인 울리플록사신에 감수성이 있는 포도구균속, 연쇄구균속, 폐렴구균, 장구균속, 모락셀라(브란하멜라)·카타칼리스, 대장균, 적리균, 살모넬라속(티푸스균, 파라티푸스균 제외), 시트로박터속, 클레브시엘라속, 엔테로박터속, 세라티아속, 프로테우스속, 콜레라균, 인플루엔자균, 녹농균, 펩토스트렙토코구스 속

<적응증>

세균성 폐렴, 만성기관지염, 만성기도질환의 감염성 악화
복합성요로감염

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의**

2008년 제5차 약제급여평가위원회 : 2008년 4월 25일

2008년 제7차 약제급여평가위원회 : 2008년 5월 21일(재심의)

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2008년 4월 14일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 5차 심의결과(2008년 제5차 약제급여평가위원회)

○ 재심의

- 국내 저항균에 대한 감수성 자료를 추가 제출토록 하여 재논의하는 것으로 심의함.

□ 7차 심의결과(2008년 제7차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 fluoroquinolone계 항생제로, 비교약제인 ciprofloxacin, levofloxacin과 효과는 유사하나 소요비용이 고가로 비용효과성이 입증되지 않았으므로 비급여함.

다. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “세균성 폐렴, 만성기관지염, 만성기도질환의 감염성 악화”, “복합성요로감염”에 허가된 경구투여 fluoroquinolone계 항생제로 ciprofloxacin, levofloxacin 등 동일 약리기전의 경구제가 급여목록에 기등재되어 있음. 따라서, 대체가능성을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당되지 않음.

○ 임상적 유용성

- Martindale 및 일본의약품집에 신청품이 수재됨.
- ■■■■환자 대상의 ■■■■과의 비교임상에서 신청품과 ■■■■의 임상효과 및 안전성(유해반응 등)에 ■■■■.
 - ■■■■¹⁾.
- 국내허가 요법과 다르나, prulifloxacin 600mg을 1일 1회 투여한 만성기관지염의 급성악화환자, 복합성요로감염환자 대상의 ciprofloxacin과의 비교임상시험, 만성 세균성 전립선염 환자 대상 levofloxacin과의 비교임상시험에서 임상적 치료면에서 유의한 차이가 없거나 동등성이 입증됨²⁾³⁾⁴⁾.
- 국내 저항균에 대한 감수성 자료는 없으며, “국내 대학병원 환자의 호흡기 검체에서 분리된 세균에 대한 퀴스논의 시험관내 항균력”자료에서, 타 약제와 감수성을 비교할 수는 없었으나, MIC를 기준으로 항균력을 비교할 때 유사하였음.
- 신청품(prulifloxacin)의 항균력은 *P.aeruginosa*, *S.pneumoniae*, *H.influenzae*에 대해서는 levofloxacin 또는 ciprofloxacin과 유사한 정도이며, *E.coli*에 대해서는 열등하고, *K.pneumoniae*에 대해서는 우수하나, *K.pneumoniae* 14균주 모두 levofloxacin에 감수성이 있었음.

○ 비용 효과성

- 임상문헌, 학회의견을 고려하여, 호흡기감염 및 비뇨기감염에 허가된 약제 중 ciprofloxacin, levofloxacin과 같이 2차로 급여인정기준이 설정된 fluoroquinolon계 항생제⁵⁾를 대체가능약제로 선정하고, 이 중 청구현황(누적 청구량 83%)을 고려하여 ciprofloxacin, levofloxacin을 비교약제로 선정함⁶⁾.
- 신청품은 학회의견 및 비교약제(ciprofloxacin, levofloxacin)와의 비교임상에서 임상효과와 안전성에 유의한 차이가 없었으므로, 투약비용 비교를 통한 비용최소화 분석으로 비용효과성을 검토한 결과, 신청품 사용이 열등전략이었음.
 - 신청품의 소요비용은 비교약제(ciprofloxacin, levofloxacin)의 소요비용보다 고가인 것으로 검토됨 [REDACTED]⁷⁾.
 - 제약사에서 경제성 평가 자료를 제출하지 않았음.

○ 재정 영향

- [REDACTED]
[REDACTED] 신청품이 대체가능한 모든 약제⁵⁾를 대상으로 검토함.
- 신청품 사용으로 인한 절대 소요비용은 [REDACTED] 검토됨⁸⁾.
- 신청품이 대체가능 약제를 제약사 제시 점유율 및 연간 예상판매량 만큼 대체할 경우, 신청품 도입으로 연간 소요비용이 [REDACTED] 증가함(등재 [REDACTED])⁹⁾.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 일본, 이태리 등에 허가되어 있음.
 - 이태리: 600mg/정 제품으로, 1회 600mg 1일 1회로 허가됨
 - 한국 및 일본 : 100mg/정 제품으로, 1회 200mg 또는 300mg 1일 2회로 허가됨.
- 신청품의 신청가는 [REDACTED] 비교 대상 약제와의 상대비율 적용 가격 [REDACTED]¹⁰⁾보다 고가에 해당됨.

REFERENCE

- 1) ■■■환자에서 퀴스논정과 ■■■의 유효성과 안전성을 평가하기 위한 ■■■임상시험 (가교임상시험)
- 2) *Respiration*. 2002;69(3):217-22
- 3) *Urol Int*. 2005;74(4):326-31
- 4) *J Chemother*. 2007;19(3):304-8
- 5) ciprofloxacin, levofloxacin, gatifloxacin, tosufloxacin, lomefloxacin, sparfloxacin, pefloxacin, rufloxacin, gemifloxacin, moxifloxacin
- 6) 2007년 연간 청구현황 기준.
- 7) 2007년 연간 가중평균가 적용. 허가사항 투여량 범위의 중간값임. 비교약제의 소요비용은 ciprofloxacin과 levofloxacin의 각각의 소요비용에 성분별 점유율을 적용하여 계산함..
- 8) 등재 3년째(2011년) 기준이며, 점유율(제약사제시 점유율 ■■■)을 통한 예상사용량 적용시 ■■■이 소요되며, 제약사 예상사용량 (■■■) 적용시 약 ■■■이 소요됨.
- 9) 등재3년째, 제약사가 제시한 점유율은 ■■■%, 연간 예상 사용량 ■■■T임.
- 10) 일본약가 : 보험약사전 (2008년 4월판) 반영